

Wgląd w koszty obron

Obrona daje krótką ulgę, ale ma długoterminową cenę: relacje, vitalność, sens. Uwidocznienie tej ceny jest motorem zmiany — bez niego pacjent nie rezygnuje z obrony.

CZAS: 30 min Sesje 3-8; gdy pacjent nie widzi problemu z obroną

ŹRÓDŁO: McCullough (1997); Abbass (2015)

JAK UŻYWAĆ

Pomagasz pacjentowi zobaczyć korzyść i koszt jego dominującej obrony. Pytasz o korzyść („co ta strategia Pani daje? Co chroni?”) i walidujesz ją — strategia miała sens. Potem uwidaczniasz koszty: w relacjach („z kim nie jest Pani bliska?”), w czasie („jeśli to utrzyma się przez 10 lat, jakie będzie życie?”) i w doświadczeniu (czego Pani nie czuje). Na końcu łączysz to z konkretnymi celami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjent, który identyfikuje obronę bez kontaktu z jej kosztem, nie ma motywacji do zmiany — „taki już jestem”, obrona jest ulgą. Koszty są zwykle **niewidoczne**: utrwalona izolacja, utrata spontaniczności, brak bliskości nie boją tak ostro jak natychmiastowa ulga. Uwidocznienie ich jest centralną interwencją motywującą (Abbass, 2015). Pod świadomością kosztów zwykle pojawia się afekt straty — smutek, złość, rozpacz — który jest materiałem dalszej pracy.

01

Nazwijcie obronę wspólnie

Wybierz jedną dominującą obronę i opisz ją jako sposób ochrony: „trzymanie dystansu, żeby nie być zranionym, to Pani sposób ochrony.”

OBRONA

CO CHRONI

— korzyść, waliduj

02

Pięć pytań o koszt

Prowadź pacjenta przez pytania, które uwidaczniają cenę — od bliskiej po projekcję w przyszłość.

- ① „Co Pani traci przez to wycofywanie się?”
- ② „Jak czuje się druga osoba, gdy Pani tak reaguje?”
- ③ „Jak długo już Pani to robi?”
- ④ „Gdyby Pani tak nie reagowała — jak wyglądałoby życie?”
- ⑤ Kontakt z bólem niespełnionych pragnień.

03 Zbilansuj korzyść i koszt

Zapisz, co obrona daje, a co odbiera — zestawienie pomaga pacjentowi zobaczyć, że ulga jest krótka, a cena długoterminowa.

CO DAJE

— krótkoterminowo

CO ODBIERA

— długoterminowo

04 Połącz z celami

„Co by się zmieniło, gdyby ta strategia rozluźniła się o 30%?” Zapisz konkretne cele w relacjach, pracy, ciele.

CELE, GDYBY OBRONA SIĘ ROZLUŹNIŁA

Klucz: nie walcz z obroną — szanuj ją. Obrona uratowała pacjenta w dzieciństwie i zasługuje na wdzięczność, nie atak. „Ta strategia uratowała Panią jako dziecko — dziękujemy jej. Pytanie: czy jest nadal potrzebna dziś?” Zmiana następuje, gdy pacjent sam uznaje, że strategia nie jest już konieczna.